

Choque hipovolêmico · classes ATLS

Classifique a hemorragia pela resposta fisiológica. Hipotensão é achado tardio — taquicardia, pele fria e ansiedade já denunciam perda importante.

Classes ATLS (resumo)

Classe | % volemia | Sinais-chave

I | < 15% | Mínimos; PA e FC estáveis

II | 15–30% | Taquicardia, ansiedade; PA normal

III | 30–40% | Hipotensão, oligúria, confusão

IV | > 40% | Choque profundo, letargia

Conduta-chave

- Controle da hemorragia (compressão, torniquete, pelve, cirurgia)
- Acessos calibrosos / IO; evitar hipotermia e coagulopatia (tríade letal)
- Em trauma penetrante/hemorragico: reposição balanceada com hemoderivados (1:1:1) quando indicado
- Permissive hypotension selecionada até controle da fonte (exceto TCE — manter PPC)

Resposta ao volume

Lembre - Resposta ao volume

Respondedor rápido, transitório ou não-respondedor guia a necessidade de cirurgia/angioembolização.

Triagem resumida: classe I–II ainda compensada; classe III–IV = choque manifesto e reposição agressiva.

Classes de hemorragia

Verde / amarelo / vermelho (visão de prova)

Classe I-II

Perda até ~15-30%
PA normal / limiar
FC normal ou elevada

Cristaloide +/- sangue

Classe III

Perda ~30-40%
Hipotensão
Oligúria / confusão

Sangue + controle fonte

Classe IV

Perda > 40%
Colapso
Letargia

Reanimação / sala

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Criança e idoso 'compensam' diferente: na criança a hipotensão é muito tardia; no ;"Ö loqueado a taquicardia pode estar ausente.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Choque hemorrágico no trauma: classificar perda volêmica (ATLS I–IV) guia reposição, sangue e controle da fonte.

Classe III já costuma ter queda de PA; classe IV = risco iminente. Use o conjunto clínico, não um número isolado.

Classes ATLS - hemorragia

Perda volêmica estimada (adulto ~70 kg)

Classe I - perda <15% (~<750 mL)	PA normal
Classe II - 15-30% (~750-1500)	PA ok / FC+
Classe III - 30-40% (~1500-2000)	PA cai
Classe IV - >40% (>2000 mL)	Choque grave
Classe I - fillip / ansiedade	Minima
Classe II - sede, FC 100-120	DEB leve
Classe III - confusão, oligúria	DEB claro
Classe IV - letargia, FC >140	DEB crítico

I <15% | II 15-30% | III 30-40% | IV >40%

Classes de hemorragia (síntese ATLS)

Classe | % perda | FC | PA | Débito urinário | CNS

I | <15% | Normal / ! leve | Normal | Normal | Ansiedade leve

II | 15-30% | 100-120 | Normal (PA diferencial !") | 20-30 mL/h | Ansiedade

III | 30-40% | 120-140 | Diminuída | 5-15 mL/h | Confusão

IV | >40% | >140 | Muito baixa | Desprezível | Letargia

Conduta-chave

Lembre - Conduta-chave

Controle da hemorragia + reanimação com sangue/produtos precoces no hemorrágico grave.

Cristaloide excessivo dilui e esfria — conceito damage control resuscitation.

Fontes ocultas no trauma

- Tórax, abdome, retroperitônio, pelve, ossos longos ('piso')
- Compressão externa, estabilização pélvica, FAST/Rx
- Evite tríade letal: hipotermia, acidose, coagulopatia

Armadilha

Atenção - Armadilha

PA normal não exclui choque classe II — olhe taquicardia, pele, sensorium e débito urinário.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1